

Fecha Última Actualización: 31-03-2022 10:23:00

Página 1 de 3

### Información Paciente

**Nombre** : Santiago Patricio Guerra Contreras  
**Edad** : 62a 6m 6d  
**Dirección** : Concha Y Toro 2346 Casa 85

**Rut** : 8.301.813-5  
**Fecha Nacto**: 25/09/1959  
**Comuna** : Puente Alto

**N° Archivo** : 2125252  
**Sexo** : Masculino  
**Teléfono** : 9 6126 6882

**N° Epicrisis**  
**300355**

### Información Hospitalización

**Unidad de Ingreso** : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

**Fecha Ingreso** : 31/01/2022 17:46

**Días Estadía**: 59

**Unidad de Egreso** : Upc - Uci Adulto

**Fecha Egreso** : 31/03/2022 10:03

### Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Sepsis

### Comorbilidades

### Procedimientos

### Intervenciones Quirúrgicas

### Epidemiología

### Resumen Clínico

EPICRISIS HOSPITALARIA

Santiago Guerra Contreras  
RUT 8301813/5  
EDAD 62  
FI HSR 01/02/2022  
FI UCI 20/02/2022

#### ANTECEDENTES

Médicos: Hiperplasia benigna prostática, dislipidemia.  
Quirúrgico: Cx de tobillo, apendicectomía.  
Fármacos: Atorvastatina, Gotely.  
Alergias no  
Inmunizaciones: Sinovac x2, AstraZeneca x1

#### ANAMNESIS:

Paciente con hospitalización reciente por una pancreatitis Balthazar E, que requirió nutrición parenteral prolongada y que cursó con sospecha de infección de colecciones, tratado con imipenem empírico 14 días. Además durante hospitalización HDA por una esofagitis grado C y una angiodisplasia antral que se trató con argón plasma. Dado de alta el 28/01, reconsulta precozmente el 31/01 por dolor abdominal y fiebre. Ingresó estable al SU y dado antecedente se decidió hospitalización en servicio de cirugía.

#### Evolución hospitalizado:

Control imagenológico al inicio de hospitalización con necrosis < 30%, con colecciones persistentes con contenido de gas en su interior que sugería sobreinfección. Dado esto más fiebre y elevación de parámetros inflamatorios se decidió cobertura con imipenem empírico y traslado a agudo quirúrgico. Con mala tolerancia gástrica, náuseas y vómitos por lo que se inició nutrición parenteral total.

Evoluciona con persistente elevación de parámetros inflamatorios, sin microbiología aislada por lo que se decidió agregar vancomicina empírica y posteriormente linezolid.

Con regular evolución clínica. Dado ausencia de microbiología aislada se planteó punción bajo EDA de colecciones, sin

**Fecha Epicrisis** : 31/03/2022 10:23

Página 1 de 3

# Epicrisis Hospitalaria

## ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 31-03-2022 10:23:00

Página 2 de 3

embargo finalmente se decidió laparoscopia para necrosectomía, aseo y toma de muestra que se realizó 18/02. Se describe escaso líquido libre de aspecto bilioso y se realizó necrosectomía de la cola.

Realiza post operatorio en recuperación, donde evolución con shock profundo, obs séptico en contexto de lo cual se traslada a UCI.

Evolución en UCI por sistemas:

Hemodinámico: Shock profundo y prolongado con marcada disfunción hemodinámica. Requirió adrenalina y noradrenalina en dosis altas. Esta última persistió durante toda la estadía al momento del traslado en dosis mínimas. Además con anemización progresiva que requirió transfusión de GR, probablemente multifactorial; inflamatoria, falla renal, pérdidas por sangrado a través de accesos, y si bien no exteriorizó sangrado se dejó con doble dosis de omeprazol dado hallazgos en EDA de hospitalización previa.

Respiratorio: Cursó con insuficiencia respiratoria asociado a un SDRA por sepsis y posteriormente atelectasias y derrame en relación a decúbito prolongado y expansión del VEC por reanimación. Buena evolución en este aspecto pero weaning prolongado por miopatía y compromiso de conciencia por lo que salió a TQT percutánea el 15/03. Logra destete del ventilador el 21/03, actualmente requiriendo O2 3 lts por TQT.

Infeccioso: Ingresa en shock séptico profundo en relación a necrosectomía pancreática, por interurrencias:

Peritonitis con cultivos intra operatorios (+) para E. coli multisensible. Al inicio con reacción leucemoide con RAN peri 50.000, PCR hasta 400. Recibió terapia prolongada con ciprofloxacino ev y anidulafungina empírica que se suspendió 10/03, con lo cual tuvo buena respuesta.

Bacteriemia por K. pneumoniae BLEE, sensible a imipenem e intermedio a meropenem que se aisló también en CVC, CAET y UC. Se decidió ajuste de terapia a imipenem ajustado por función renal con lo cual tuvo evolución favorable.

Posteriormente con nueva alza de parámetros inflamatorios y broncorrea abundante se tomaron cultivos sin escalar en terapia antibiótica, sin aislar agente.

En relación a compromiso de conciencia se solicitó TAC de cerebro que mostró múltiples lesiones descritas más abajo, probables abscesos y probable foco hematógeno. Paciente portador de un soplo sistólico. Ante sospecha de endocarditis se solicitó ETT que está pendiente y se discutió con infectología; no se puede descartar implantes en relación a bacteriemia conocida, paciente con hemodiálisis diarias se pensó en que dosis de imipenem era sub óptimas y se decidió dosis altas según función renal. Pendiente estudio de lesiones SNC con resonancia magnética.

Al momento del traslado afebril, tranquilo, con parámetros inflamatorios estacionarios con PCR peri 100 y leucocitosis 15000 - 20000.

Renal: En relación al shock profundo y FOM cursó con deterioro de función renal y cayó en TRR. Muy urémico y con difícil manejo de balances requirió diálisis diarias (según disponibilidad). VEC muy expandido con VCE contraído requirió volemicización con coloides en múltiples ocasiones. Al momento del traslado impresiona con leve mejoría de función renal, diuresis peri 500 cc y menos urémico (plantearse recolectar orina para clearance para ajuste de terapias).

Hepático: En relación a FOM cursó con hepatitis isquémica con extensas áreas de infarto hepático en TAC. Con hiperbilirrubinemia marcada y transaminasas > 1000. Al momento del traslado con bilirrubina a la baja, INR estabilizado y transaminasas en normalización

Tromboembólico: Cursó con trombosis portal pesquisada en TACs abdominales. Se manejó con bomba de heparina que tuvo que ser suspendida por lesiones cerebrales.

Neurológico: Posterior a suspensión de sedación paciente con compromiso de conciencia persistente que en un inicio fue atribuido a causas metabólicas. Dado persistencia se decidió estudiar con un EEG que no mostró actividad epileptiforme y un TAC/angioTC de cerebro que mostró una lesión grande fronto-parietal izquierda con realce en anillo y edema perilesional. Asociada a esta, abundantes lesiones satélites bilaterales. Sin urgencia desde el punto de vista neuroquirúrgico, el diagnóstico diferencial incluye abscesos (secundario probablemente a infección diseminada por K. pneumoniae) y metástasis y debe hacerse con resonancia magnética que está pendiente. De momento se inició profilaxis antiepileptica con levetiracetam ajustado por función renal.

Quirúrgico: Posterior a laparoscopia y necrosectomía del 18/02 sin nuevas intervenciones. Quedó con dos drenajes tubulares con contenido francamente purulento, con débito progresivamente menores. Dado ileo adinámico recibió nutrición parenteral prolongada. Se intentó inicio de nutrición enteral con regular tolerancia. Se conversó con nutrición instalar una nasoyeyunal a discutir con cirugía.

Diagnósticos de egreso:

- Obs abscesos cerebrales en estudio
  - ¿Siembra hematógena?
- Bacteriemia por K. pneumoniae obs foco urinario

Fecha Epicrisis : 31/03/2022 10:23

Página 2 de 3

# Epicrisis Hospitalaria

## ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 31-03-2022 10:23:00

Página 3 de 3

- Peritonitis por E. coli
- Shock séptico foco abdominal secundario a Pancreatitis necrohemorrágica con falla multiorgánica (Respiratoria/Hemodinámica/Hepática con coagulopatía/Renal/Metabólica/Hematológica/Rabdomiolisis) SOFA 18
- 18/02 Necrosectomía parcial laparoscópica de la cola del páncreas
- Tromboflebitis de vena mesentérica superior. Trombo en vena porta principal
- IOT 18/02
- TQT 15/03

Estando en sala paciente presenta nuevo cuadro séptico y falla ventilatoria. Por ese motivo debe volver a UCI y se conecta por su TQT a VMI.

En UCI paciente no logra recuperarse, cae en falla orgánica múltiple. Se toman exámenes e imágenes que denotan progresión de sus colecciones abdominales. Se concuerda con cirugía que no es susceptible de operarse ni de puncionarse motivo por el cual se decide manejo conservador con ATB.

paciente evoluciona mal en franca falla respiratoria, circulatoria y renal, constatándose el día 31-03-22 a las 10:10 hrs su fallecimiento.

### Diagnóstico de Egreso

Shock séptico -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

fallece

### Plan Post Alta

fallece

### Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

### Controles

INTERNO

  
Loreto Valentina Hernández Alvar  
Becado/Residente

  
Andres Aquevedo Salazar  
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 31/03/2022 10:23

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 13:10

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar